



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| נוהל מס':                          |  |
| שם הנוהל: נוהל אצירת שתן לאחר לידה |  |
| JCI CODE                           |  |

| תאריך עדכון:<br>1.2.2022<br>תאריך פרסום;<br>1.6.2014                                                                                                                                                                                                                                                  | תחום הנוהל: רפואי סעודי                                          |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | שם הנוהל;<br>נוהל אצירת שתן לאחר לידה                            |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>מאשר הנוהל:</b><br>פרופ' ויינר זאב<br>מנהל מערך נשים ומיילדות | <b>כותבי הנוהל:</b><br>אלינה ליכטצינדר<br>מיכל קרנצלר<br>מישל שלומוביץ'<br>בטי גרינברג<br>ד"ר גלעד פילמר |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>על החתום:</b><br>פרופ' ויינר זאב                              |                                                                                                          |
| <b>תפוצה:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- מנהל מערך נשים ומיילדות</li><li>- מנהלת הסיעוד מערך נשים ומיילדות</li><li>- מנהל חדר לידה</li><li>- מנהל מחלקת נשים</li><li>- אחיות אחראיות</li><li>- נשים</li><li>- יולדות א</li><li>- יולדות ב</li><li>- חדר לידה</li><li>- תינוקות</li></ul> |                                                                  |                                                                                                          |
| <b>אישור אחראית תחום סיעודי:</b><br>מיכל קרנצלר, מנהלת הסיעוד בחטיבת מיילדות גניקולוגיה<br><b>על החתום:</b><br>מיכל קרנצלר                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                          |

**רשימת עדכונים:**

| מהדורה | מהות העדכון    | שם המעדכן ותפקיד                                 | תאריך    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| 2      | התאמות לדרישות | ד"ר ניר חייא<br>ד"ר ויטנר דנה<br>אלינה ליכטצינדר | 1.2.2022 |

**מילות מפתח (KEY WORDS):**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| שתן אצירת שתן, שארית שתן, קטטריזציה לאחר לידה |
|-----------------------------------------------|



מב'ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| נוהל מס':                          |  |
| שם הנוהל: נוהל אצירת שתן לאחר לידה |  |
| JCI CODE                           |  |

## 1. רקע:

- אצירת שתן לאחר לידה** הינה תופעה נפוצה, שכיחות התופעה מ 1.7-17.9% [1,2]. הטווח הרחב נובע מהגדרות שונות ותת דיווח, מאחר וחלק לא מבוטל של יולדות ללא תסמינים ועל כן אינן מאובחנות. אצירת שתן לאחר לידה היא לרוב ברת חולף, כי 92% מהיולדות אשר הוגדרו כסובלות מהפרעת התרוקנות לאחר הלידה יצליחו להתרוקן באופן תקין תוך מספר ימים.
- 1.1. אצירת שתן לאחר לידה ככל הנראה קשורה לנזק זמני לעצב הפודנדלי במהלך הלידה.
  - 1.2. **גורמי סיכון** הקשורים להתפתחות אצירת שתן הם: שלב שני מאורך, הרדמה אפידורלית, לידה מכשירנית, בצקת ניכרת של איזור העריו, קרעים נרחבים בתעלת הלידה, אצירת שתן בעבר [1,3]
  - 1.3. **סיבות אחרות** התורמות להיווצרותה הן: לחץ נפשי לאחר לידה, תנוחה לא טבעית של מתן שתן (בשכיבה עקב מתן סיר), סביבה שונה להטלת שתן.
  - 1.4. אצירת כמות רבה של שתן עשויה לגרום לתת תפקוד של השריר העוטף את שלפוחית השתן ואחראי על התכווצות (הדטרזור) ולהפרעת התרוקנות ממושכת, כמו גם עליה בלחץ התוך כלייתי עד כדי פגיעה בתפקוד הכליות ועליה בסיכון לזיהום.

## 2. מטרות הנוהל:

- 2.1. מניעת נזק לשלפוחית השתן בעקבות אצירת שתן ממושכת באמצעות שתי דרכים עיקריות:
  - מעקב אחר מתן שתן במהלך הלידה ולאחר הלידה במטרה למנוע התרחבות יתר של שלפוחית השתן.
  - זיהוי מוקדם וטיפול באצירת השתן לאחר הלידה.

## 3. הגדרות ומונחים:

- 3.1. **אצירת שתן גלויה** הינה **חוסר יכולת להתרוקן 6 שעות** לאחר לידה נרתיקית או שש שעות לאחר קטטריזציה אחרונה שמלווה בדרך כלל בכאבים או ברגישות באזור שלפוחית השתן שמעלה צורך בקטטריזציה.
- 3.2. **אצירת שתן סמויה** הינה **שאריית שתן של לפחות 150 מ"ל כ-6 שעות** לאחר הטלת שתן ספונטנית או מקטטריזציה אחרונה, כפי שנמדדת בקטטריזציה יזומה או בהערכת אולטרסאונד. [2]
- 3.3. **הפרעה בהטלת שתן תוגדר במקרים הבאים:**
  - היעדר מתן שתן 6 שעות אחרי לידה נרתיקית
  - היעדר מתן שתן 6 שעות אחרי קטטריזציה מכל סיבה (ניתוח קייסרי/ אצירת שתן קודמת/לידה מכשירנית/תפירה)
  - שארית שתן מעל 150 סמ"ק לאחר התרוקנות ספונטנית (על ידי אולטרסאונד או קטטריזציה).



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| נוהל מס':                          |  |
| שם הנוהל: נוהל אצירת שתן לאחר לידה |  |
| JCI CODE                           |  |

#### 4. סמכות ואחריות;

| הגדרת תחומי האחריות/סמכות                                                         | הגורם    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| החלטה על צנתור והוצאת קטטר פולי                                                   | 4.1 רופא |
| ביצוע קטטריזציה (Bladder Scan)<br>טיפול ומעקב אחר היולדת<br>דיווח על מקרים חריגים | 4.2 אחות |

#### 5. שיטת הביצוע/הנחיות:

##### 5.1 בחדר לידה:

- באחריות המיילדת **במהלך הלידה** לעודד את היולדת להטלת שתן ספונטני כל 3 שעות או לחילופין לבצע קטטריזציה במידה וזוהתה שלפוחית שתן מלאה.
- על כל קטטריזציה או הטלת שתן ספונטנית של יולדת יש לדווח ברשומות סיעודיות
- **בהעברת היולדת למחלקה** חובה לדווח על הטלת שתן או על קטטריזציה ברשומות סיעודיות ממוחשבות.
- במידה ויולדת לא הטילה שתן ספונטנית ולא צונתרה בשחרור למחלקה יש לציין שעת הטלת שתן אחרונה.
- במידה ומהטלת השתן האחרונה עברו **4 שעות** יש לדאוג להטלת שתן ספונטנית או לצנתור חד פעמי.
- במידה ובשחרור יולדת למחלקה ישנם ממצאים גופניים (גובה רחם גבוה, מורגשת שלפוחית שתן מלאה) התומכים בקיום שארית שתן, יש לדאוג להטלת שתן ספונטנית או קטטריזציה חד פעמית גם אם עדיין לא עברו 4 שעות.
- אין לשחרר יולדת מחדר לידה למחלקה עם אומדן שתן/אומדן גובה רחם/הטלה אחרונה יותר מ 4 שעות אחרונות ללא טיפול בשארית שתן והתייחסות ברשומה הרפואית.

##### 5.2 במחלקת יולדות/נשים

- באחריות צוות המחלקה בקבלה של יולדת לאסוף מידע על הטלת שתן אחרונה בחדר לידה.
- דיווח על הטלת שתן היולדת יירשם כל משמרת באומדן שתן כחלק מאומדני חובה במשך כל האשפוז של היולדת.
- הכנסת קטטר והוצאתו יתבצע לאחר מתן הוראה רפואית ויתועד ברשומות.



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| נוהל מס':                          |  |
| שם הנוהל: נוהל אצירת שתן לאחר לידה |  |
| JCI CODE                           |  |

### 5.3 במהלך 48 שעות ראשונות יש לפעול לפי כללים הבאים:

- **הנחת יסוד 1:** יולדת לאחר לידה או מקטריזציה אחרונה אמורה לתת שתן במשך 6 שעות.
- **הנחת יסוד 2:** יולדת שהוגדרה כסובלת מאצירת שתן וטופלה על ידי קטטריזציות אמורה לעבור הערכת אולטרסאונד לאחר הטלת שתן ספונטנית **ראשונה** לצורך זיהוי שארית שתן סמויה.
- **תדירות של קטטריזציות** - כל 6 שעות או לפי מצב קליני של מטופלת במשך 48 שעות ראשונות, קטטריזציות חד פעמיות ללא קשר לנפח של שארית שתן.

**5.3.1 בעת קבלת היולדת למחלקה ובמהלך 6 שעות** הראשונות יבוצע **תשאול יזום** של היולדות אודות אופן מתן השתן, תבוצע **בדיקה גופנית (גובה רחם ומישוש של שלפוחית שתן) בקבלתה, שעתיים לאחר קבלתה למחלקה ולאחר הטלת שתן ראשונה** לצורך זיהוי בעיות התרוקנות והתאמת טיפול בהתאם. במידה וכל הממצאים תקינים, יולדת מדווחת על תחושת התרוקנות טובה והטלת שתן ללא קשיים, יש לדווח ברשומות ובהמשך תשאול יזום כל משמרת.

**5.3.2 יולדת שזוהתה כסובלת מאצירת שתן**, שמלווה באי נוחות וכאב תעבור קטטריזציה חד פעמית, ובהמשך תעבור קטטריזציות חד פעמיות כל 6 שעות או לפי מצבה הקליני. תבוצע הערכת אולטרסאונד לאחר הטלת שתן ראשונה.

**5.3.3 יולדות שהטילה שתן ספונטנית**, אך עולה **חשד להפרעת התרוקנות** (התרוקנות בזרם שתן איטי או תחושת התרוקנות לא מלאה) יש לבצע הערכת אולטרסאונד להערכת שארית שתן. במידה ואין אפשרות לבצע אולטרסאונד, ניתן לבצע קטטריזציה אבחנתית. **שארית שתן מעל 150 מל' לאחר הטלת שתן ספונטנית דורשת קטטריזציה חד פעמית.**

**5.3.4 יולדת אשר טרם הטילה שתן במשך 6 שעות לאחר הלידה/ניתוח קיסרי/קטטריזציה אחרונה ואינה חשה צורך בכך**, תעבור הערכה סונוגרפית לפני החלטה על קטטריזציה. במידה ושארית שתן בהערכת אולטרסאונד פחות מ-150 מל' ובדיקה גופנית לא תומכת בשארית שתן גדולה ניתן לחכות עד שעתיים נוספות.

**5.3.5 אצירת שתן שנובעת מבצקת משמעותית של איזור הפרינאום** תטופל על ידי קטטריזציה קבועה. הערכת בצקת ונחיצות של קטטר פולי יתבצע כל משמרת על ידי אחות מטפלת. החלטה סופית על הישארות או הוצאתו של קטטר תתקבל על ידי רופא.

**5.3.6 במידה ויולדת מעוניינת, יש לשקול** בחיוב התערבות משלימה באמצעות **דיקור סיני**, שיעילותו נבחנה ונמצאה יעילה באופן חלקי (3), טיפול הזה אינו תחליף לקטטריזציה.

**5.3.7 במשך האשפוז יש להציע ליולדת פיזיותרפיה** לצורך שיפור תפקוד ריצפת האגן.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| נוהל מס':                          |  |
| שם הנוהל: נוהל אצירת שתן לאחר לידה |  |
| JCI CODE                           |  |

#### 5.4. שחרור יולדת הסובלת מאצירת שתן

##### 5.4.1 יולדת עומדת בפני שחרור ועדיין סובלת משארית שתן גדולה של מעל 150 מ"ל יש

לדון עם היולדת ולהציג בפניה שתי אפשרויות:

1. שימוש בקטטר שתן קבוע המחובר לשקית רגל וניסיון גמילה במסגרת אמבולטורית.
  2. ביצוע קטטריזציות עצמאיות:
- ניתן לתאם הדרכה עם צוות הסיעודי של מרפאה נירוראורולוגית (האחות נר).
  - במידה והדרכה לא מתאפשרת במהלך האשפוז, היולדת תשוחרר עם קטטר קבוע. יש להנחות את היולדת לקבלת הדרכה לקטטריזציה עצמאית במסגרת אמבולטורית.
  - היולדת בשחרורה תקבל מרשם לקטטרים בקוטר FR12 (קטטרים יעודים קצרים בעלי מוליך) וחומרי חיטוי לקטטריזציה.
  - בחלק ממרפאות קופת חולים קיים שירות להדרכת קטטריזציות עצמית. יש בשחרור של היולדת להמליץ ליצור קשר עם:
- למבוטחי כללית** – מרפאת לין - אורולוגיה – 04-8568358 לתיאום תור  
**מבוטחי מכבי** – 3555\*
- חברת COLOPLAST** מעניקה שירות של הדרכת אחיות בבית המטופלת.  
 טלפונים: 054-5401071  
**מרכז מידע** – 1800696968
- המשך מעקב רפואי יבוצע ע"י הצוות האורוגניקולוגי (ד"ר ניר חייא וד"ר גלעד פילמר) במרפאות חוץ נשים.

#### 5. **דיווח ותייעוד;**

כמקובל, בכל הרצף הטיפולי, בחדר לידה ובמחלקות האשפוז ביולדות נשים.

#### 6. **מסמכים ישימים (סימוכין):**

1. Saultz JW, Toffler WL, Shackles JY. Postpartum urinary retention. J Am Board Fam Pract 1991; 4: 341–4. [2]
2. Yip SK, Brieger G, Hin LY, Chung T. Urinary retention in the post-partum period: the relationship between obstetric factors and the post-partum post-void residual bladder volume. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76: 667–72.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| נוהל מס':                          |          |
| שם הנוהל: נוחל אצירת שתן לאחר לידה |          |
|                                    | JCI CODE |



3. Lauterbach, Roy, et al. "Acupuncture for the treatment of post-partum urinary retention." *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 223 (2018): 35-38.